

初期対応



注意すべき症状

急激な血圧低下の前駆症状

- 生あくび
- 冷汗
- 顔面蒼白
- 急な便意
- など

呼吸困難の前駆症状

- 咳込み
- 喉のかゆみ
- 喘鳴
- くしゃみ
- 声のかすれ
- など

痙攣・てんかん出現

- 痙攣発作
- 意識障害
- など

POINT

タイミングを逸せず初期対応へ。

初期対応

同時進行で以下の対応を行う。

●造影剤投与中止

●輸液セットを留置針から外し、注射器で針の中の造影剤を吸引する。吸引後は、そこに生理食塩水のルートをつなぐか、又は、別ルートを確認する。
(留置針は20G以上が望ましい)

①意識障害 ②呼吸困難
③ショック状態のうち
いずれかある場合は

ハリーコール

①②③がない軽症の場合は、担当医コール

MRIの場合は、
患者をMRI室から出す

●バイタルサインのチェック（意識レベル 呼吸 血圧 脈拍 皮膚の状態等の観察）●パルスオキシメーター、モニターの装着

痙攣・てんかんへの対応

○頻脈

○皮膚・粘膜症状あり

○呼吸器症状あり

アナフィラキシー疑い

アドレナリン筋注

アナフィラキシーセットの準備

呼吸管理

呼吸困難への対応

循環管理

血圧低下への対応

○徐脈

○皮膚・粘膜症状なし

○呼吸器症状なし

血管迷走神経反射疑い

血圧低下への対応

2024年6月

長崎百合野病院医療安全管理部
放射線科